



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



„BEZ STRESU DO SUKCESU – Terapia neurologiczna przyjazna dziecku”

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Dostępności” –

Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kraków 2021



MAŁOPOLSKA



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO



SPIS TREŚCI

OPIS GRUPY DOCELOWEJ I ODBIORCÓW ROZWIĄZANIA	3
OPIS ROZWIĄZANIA I METODY.....	8
OPIS KWALIFIKACJI SPECJALISTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE „BEZ STRESU DO SUKCESU”	10
WYNIKI TESTÓW I REKOMENDACJE I ZALECENIA DLA PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW GRY	10
PODSUMOWANIE.....	12
ZAŁĄCZNIKI.....	13
Zajęcia terapeutyczne FIZJOTERAPEUTA – DOGOTERAPEUTA	13
WARIANT 1	13
WARIANT 2	14
Zajęcia terapeutyczne FIZJOTERAPEUTA – PSYCHOLOG	15
WARIANT 1	15
WARIANT 2	15

OPIS GRUPY DOCELOWEJ I ODBIORCÓW ROZWIĄZANIA

Grupa docelowa złożona była z 10-ciorga dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością lub nią zagrożonych. Dzieci biorące udział w projekcie mieściły się w przedziale wiekowym od 9 miesięcy do 3 lat. Były to dzieci, które obarczone są zaburzeniami rozwojowymi wymagającymi intensywnej opieki terapeutycznej min.: epilepsją, wadami wrodzonymi, zespołem Downa, zaburzeniami napięcia mięśniowego.

U każdego z nich deficyty są wielopłaszczyznowe, dlatego wsparcie terapeutyczne powinno odbywać się wielotorowo (rehabilitant, pedagog, psycholog, terapeuta Si, dogoterapeuta).

Dzieci w pierwszych latach życia charakteryzują się nieustającą potrzebą ruchu. Niestety nie każdemu taka szansa jest dana. Dzieci objęte projektem borykają się ze schorzeniami uniemożliwiającymi im poruszanie się w stopniu całkowitym lub niepełnym lub są tym zagrożone, a to wiąże się z deformacjami ciała. Niepełnosprawność ruchowa u tych dzieci wpływa niekorzystnie na ich możliwości edukacyjne ponieważ każda aktywność związana jest z poruszaniem się (korzystanie z toalety, siadanie do posiłków, wychodzenie na spacer itd.) – nawet jeśli stopień ruchu jest minimalny, to jednak stanowi on dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu poważne ograniczenie.

Brak należytej opieki specjalistycznej, zdecydowanie obniża możliwości poznawcze dziecka, wzmacnia poczucie wstydu, co może prowadzić do wyobcowania dziecka ze środowiska rówieśniczego. Dzieci z niepełnosprawnością często są chwiejne emocjonalnie, potrzebują nie tylko wsparcia w postaci aktywności fizycznej, doboru sprzętu i pomocy w ubieraniu, lecz także ważne są dla nich okazywane im emocje. Często dzieci z niepełnosprawnością ruchowo nie potrafią właściwie okazywać emocji, lecz oczekują ciepła, uznania od innych, co jest zrozumiałe.

W teście brały udział dzieci, które ze względu na wiek, prezentowane trudności w tym także obniżony poziom koncentracji uwagi oraz ilość oddziaływań zakresu opieki medycznej narażone są na dyskomfort, stres i niejednokrotnie odmawiają współpracy z terapeutą.

Grupa testowa składa się z dziesięciorga dzieci obarczonych trudnościami rozwojowymi reprezentujących różnego rodzaju dysfunkcje:

Gabrysia K.

Trisomia 21 chromosomu, brak wad współistniejących

Dziewczynka z znacznym obniżonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem psycho – ruchowym, niemówiąca, z deficytem uwagi i obniżonym poziomem motywacji do podejmowania różnego rodzaju aktywności w tym działań terapeutycznych, ale z dużą potrzebą ruchu.

Obszar do pracy z Gabrysią:

wzmacnianie mięśni posturalnych, poprawa wzorca chodu, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, stymulacja czucia głębokiego, usprawnianie małej motoryki (poprawa wzorca chwytu), rozwój komunikacji.

Ola G.

Trisomia 21 chromosomu, współwystępująca wada serca

Dziewczynka ze znacznie obniżonym poziomem pobudzenia ruchowego oraz ze znacznie obniżonym rozwojem psychoruchowym w stosunku do wieku. Niemówiąca, korzystająca z kilku gestów komunikacyjnych (koniec, jeszcze, jeść, pić) deficytem uwagi i obniżonym poziomem motywacji do podejmowania różnego rodzaju aktywności w tym działań terapeutycznych.

Obszar do pracy z Olą: wzmacnianie mięśni posturalnych, poprawa wzorca chodu, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, stymulacja czucia głębokiego, usprawnianie małej motoryki (poprawa wzorca chwytu), rozwój komunikacji oraz pobudzanie do podejmowania działań.

Piotr P.

Obciążony wywiad okołoporodowy – encefalopatia, padaczka, opóźniony rozwój ruchowy, rozszczep podniebienia.

Funkcjonuje na poziomie pogranicza niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim a umiarkowanym.

Chód niestabilny na szerokiej podstawie, często traci równowagę, brak poczucia zagrożenia podczas aktywności ruchowych, duża potrzeba ruchu, nieskoordynowanie w działaniach, trudności w zakresie planowania motorycznego i współpracy rąk, brak rozwoju mowy czynnej, brak rozumienia komunikatów werbalnych, bardzo krótka i przerzutna koncentracja uwagi.

Obszar do pracy:

Wzmacnia mięśni posturalnych, poprawa wzorca chodu, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, stymulacja czucia głębokiego, usprawnianie malej motoryki (poprawa wzorca chwytu), rozwój komunikacji oraz pobudzanie do podejmowania działań. Wspieranie gestem komunikatów celem poprawy rozumienia.

Mieszko S.

Dystrofia mięśniowa Duchenna

Zaburzenia napięcia mięśniowego, równowagi i czucia głębokiego. Brak adekwatnego do wieku rozwoju mowy i komunikacji, trudności adaptacyjne, labilność emocjonalna przerzutna i podatne na dystraktory koncentracji uwagi.

Obszar do pracy:

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, wzmacnia mięśni posturalnych, poprawa wzorca chodu, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, stymulacja czucia głębokiego, usprawnianie malej motoryki (poprawa wzorca chwytu), rozwój komunikacji.

Jan G.

W obserwacji endokrynologicznej z uwagi na niski wzrost.

Opóźniony rozwój psychoruchowy, często chód na palcach z uwagi na wzmożone napięcie w kończynach dolnych. Niezborność ruchowa (częste potykanie się).

Obszar do pracy:

Normalizacja napięcia mięśniowego, stymulacja czucia głębokiego, poprawa wzorca chodu. Stymulacja koordynacji wzrokowo – ruchowej. Wpływ na obniżenie poczucia zagrożenia i lęku podczas terapii.

Ada G.

Asymetria ułożeniowa, wzmożone napięcie ruchowe, koślawość kończyn dolnych, stopy ułożone w koślawości, chód na palcach, przodopochylenie miednicy, odstające kąty łopatek, duża potrzeba ruchu, trudności motywacyjne

Obszar do pracy:

Normalizacja napięcia mięśniowego, poprawa wzorca chodu, praca na prawidłowym ustawieniu miednicy, ćwiczenia równoważne, stymulacja czucia głębokiego.

Kamil D.

W trakcie diagnozy ze względu na występujące torbiele w mózgu.

Opóźniony rozwój psychoruchowy. Zaburzone napięcia mięśniowe, ustawienie stóp w koślawości, przykurcz mięśni kulszowo – goleniowych oraz biodrowych

Trudności adaptacyjne, silny stres w nowej sytuacji.

Obszar do pracy :

Rozciąganie mięśni przykurczonych z grupy kulszowo goleniowych, pośladkowych oraz biodrowo – lędźwiowych oraz mięśni stóp. Wzmacnianie mięśni posturalnych, obniżenie poziomu stresu, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.

Marianna L.

W trakcie diagnozy ze względu na opóźnienie psychoruchowe, w obserwacji neurologicznej.

Silny lęk separacyjny hamujący chęć podejmowania działań. Trudności adaptacyjne, opóźniony rozwój mowy, trudności manipulacyjne, nieprawidłowy chwyt. Zaburzenia rozumienia mowy oraz analizy i syntezy wzrokowej.

Kręczy szyi, obniżone napięcie mięśniowe, opóźnienie osiągania kamieni milowych w rozwoju, trudności z przekroczeniem linii środkowej.

Obszar do pracy:

Normalizacja napięcia mięśniowego, nauka chodu, praca nad prawidłowym ustawieniem miednicy podczas siadu, stymulacja czucia głębokiego, wzmacnianie mięśni przykurczonych, praca nad rozciągnięciem mięśnia mostkowo – obojczykowo – sutkowego.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa i stymulacja rozwoju poznawczego

Nadia G.

Opóźniony rozwój psychoruchowy

Asymetria ułożeniowa, koślawość kolan, stopy płasko – koślawe, przodopochylenie miednicy, wystający brzuszek, rozstęp mięśnia prostego brzucha, odchylenie kątów łopatek, zaokrąglone plecy.

Obszar do pracy:

Wzmacnianie mięśni posturalnych, praca nad rozciągnięciem mięśni przykurczonych i normalizacja napięcia mięśniowego. Poprawa wzorca chodu oraz nauka skakanie, biegania i pokonywania przeszkód.

Michał K.

Opóźniony rozwój psychoruchowy, podejrzenie padaczki

Dziecko z hipotonią mięśniową, pod kontrolą neurologa. Brak osiągniętych kamieni milowych oczekiwanych z uwagi na wiek.

Obszar do pracy:

Wzmacnianie mięśni posturalnych, praca nad osiągnięciem symetrii ciała. Stymulacja rozwoju ruchowego: nauka obrotów z pleców na brzuch, unoszenia nóżek w pozycji pronacyjnej, przekraczanie linii środkowej ciała.

OPIS ROZWIĄZANIA I METODY

Celem programu „Bez stresu do sukcesu” było przeprowadzenie terapii dzieci z niepełnosprawnościami wg nowego modelu, który zakłada integrację i synergę oddziaływań metody NDT Bobath oraz dodatkowych stymulantów psychofizycznych. Każde z zajęć prowadzone było przez dwójkę specjalistów: fizjoterapeutę oraz psychologa/dogoterapeutę (na przemienne). Wprowadzenie do terapii dodatkowej osoby miało na celu wzmocnienie efektywnych działań rehabilitanta przy jednoczesnym zminimalizowaniu lub uniknięciu obciążeń emocjonalnych terapii.

Zadaniem fizjoterapeuty było:

- ocena spontanicznej aktywności ruchowej dziecka,
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
- badanie palpacyjne dziecka (badanie siły mięśniowej, zakresu ruchomości dziecka, napięcia mięśniowego,
- zaplanowanie terapii,
- przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem metody NDT Bobath i innych metod manualnych
- masaż dziecka,
- nauka rodziców prawidłowej pielęgnacji dziecka (odpowiednie noszenie, podnoszenie, przewijanie dziecka),
- przekazanie zestawu ćwiczeń do domu.

Zadania psychologa dziecięcego:

- ocena predyspozycji psychofizycznych dziecka,
- dbałość o poziom motywacji dziecka do podejmowania aktywności ruchowych,
- wzbudzanie motywacji wewnętrznej dziecka do podejmowania wysiłku,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecka podczas terapii,
- dbałość o stan emocjonalny dziecka,
- kontakt z rodzicem,
- przygotowanie odpowiednich zadań dla dziecka,
- odwracanie uwagi dziecka od wykonywanych ćwiczeń przez fizjoterapeutę,
- poprawa koncentracji uwagi,
- wprowadzanie technik relaksacyjnych.

Zadania dogoterapeuty:

- odwracanie uwagi od trudnych aktywności poprzez zabawę z psem,
- wyciszenie negatywnych emocji poprzez kontakt z psem,
- motywowanie do podejmowania działań,
- zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i relaksu,
- poprawa kondycji psychicznej,
- rozwijanie spostrzegawczości,
- korygowanie zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
- stymulowanie funkcji poznawczych,
- wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej.

Obecność psa wspomaga tradycyjne postępowanie terapeutyczne, które staje się przyjemne w szczególności dla najmłodszych pacjentów, którzy nie zawsze wyrażają chęci do ćwiczeń. Pies pomaga ćwiczyć i rozwijać umiejętności potrzebne do przywrócenia sprawności, zwiększa skupienie uwagi i poprzez kontakt dotykowy z dzieckiem wpływa na normalizację napięcia mięśniowego.

OPIS KWALIFIKACJI SPECJALISTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE „BEZ STRESU DO SUKCESU”

W założonym projekcie brało udział trzech specjalistów:

- fizjoterapeuta dziecięcy
- dogoterapeuta
- psycholog

Fizjoterapeuta dziecięcy – uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii

Rekomendowane ukończenie kursów : NDT -Bobath , Vojta

Psycholog dziecięcy - uzyskanie tytułu magistra psychologii

Rekomendowane: kończenie licznych szkoleń z zakresu pracy z emocjami małego dziecka, rozwoju poznawczym oraz społecznym.

Dogoterapeuta -

Uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

WYNIKI TESTÓW I REKOMENDACJE I ZALECENIA DLA PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW GRY

Test został przeprowadzony w okresie od czerwca 2021 do końca sierpnia 2021 roku. Część spotkań (8 dzieci) miała miejsce w żłobku samorządowym numer 19 przy ul. Świtezianki 7 w Krakowie, a z pozostałą dwójką zajęcia odbywały się w gabinecie prywatnym „Zobacz jak rosnę” przy ulicy Księcia Józefa 54a w Krakowie.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach regularnie raz lub dwa razy w tygodniu. Pięcioro dzieci odbywało regularnie zajęcia z dogoterapeutą, a pięcioro realizowało je przy udziale psychologa.

Podczas spotkań realizowano indywidualne założenia terapeutyczne wynikające z wcześniej przeprowadzonej diagnozy.

Wyniki testu pracy w towarzystwie psychologa:

U czwórki dzieci od pierwszych zajęć wyraźnie zwiększone poczucie bezpieczeństwa.

Wzrósł poziom motywacji do uczestniczenia w proponowanych aktywnościach.

Wielokrotnie skutecznie odwrócono uwagę od oddziaływań manualnych fizjoterapeuty.

Nastąpił szybszy przebieg procesów adaptacyjnych.

U jednego dziecka 9 miesięcznego, którego terapia była przeprowadzana w gabinecie prywatnym w obecności rodzica nie zauważono wpływu na łagodzenie lęku separacyjnego. Jednak kontakt psychologa z rodzicem wpływał na komfort i poczucie bezpieczeństwa rodzica w procesie terapii jego dziecka.

U jednego z dzieci utrzymywał się silny lęk przed kontaktem z osobą terapeuty, w wyniku czego żadne z oddziaływań psychologa nie przyniosło pozytywnych efektów.

Wyniki testów pracy w towarzystwie dogoterapeuty:

Kontakt z psem wyraźnie motywował wszystkie dzieci do działania. Pies był motywatorem do podejmowania trudnych aktywności ruchowych. Dzieci nie reagowały na stymulacje dotykową wykonywaną przez fizjoterapeutę. Zwiększył się czas koncentracji uwagi, poprawił się poziom komunikacji u dzieci. Kontakt z psem wpłynął na rozwój motoryki małej.

Obecność psa wpłynęła pozytywnie na trudności separacyjne zarówno z opiekunem żłobkowym jak i rodzicem.

W kontakcie z psem rehabilitacja przebiegała sprawniej płynniej i efektywniej.

Pod koniec terapii dzieci były bardziej zrelaksowane, mniej napięte przez co zwiększył się ich poziom poczucia bezpieczeństwa przy kolejnych spotkaniach.

Błędem w założeniach testowania zarówno w pracy z dogoterapeutą jak i psychologiem było uwzględnienie półtoragodzinnego czasu prowadzenia terapii.

Efektywny czas działania terapii to 60 minut pracy z dzieckiem.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rzadziej wykazywały lęk, nie były świadome procesów przebiegu terapeutycznego dlatego specjaliści wspierający terapię bardziej wpływały na procesy motywacyjne niż te związane z komfortem emocjonalnym dziecka podczas terapii.

Błędem było również brak ujęcia w planowaniu testów udziału psychologa i dogoterapeuty z każdym uczestnikiem testu. Taki działanie dałby możliwość porównania wpływu oddziaływań dwóch różnych specjalistów i pełnej oceny ich skuteczność.

REKOMENDACJE:

- Wybór terapeuty do dziecka powinien być uzależniony od jego indywidualnych predyspozycji psychofizycznych oraz wieku dziecka
(starsze dzieci współpracują lepiej z dogoterapeutą, a młodsze z psychologiem)
- Czas terapii powinien być dostosowany indywidualnie do uczestnika.
W przypadku najmłodszych dzieci uzależniony jest od pory dnia, kondycji psychofizycznej, a także od możliwości uwagowych i kondycyjnych dziecka
- W przypadku dzieci starszych oraz wysoko wrażliwych rekomenduje się terapię bez udziału rodzica, a ewentualne wskazówki do kontynuacji pracy w domu powinna być przekazywana po zakończonej terapii.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone testy miały na celu zweryfikować potencjalny wzrost skuteczności terapii realizowanej przez fizjoterapeutę we współpracy z innymi specjalistami. Największych efektów spodziewano się w zakresie obniżenia poziomu leku, wzrostu poziomu motywacji do podejmowania aktywności oraz zapewnienie komfortu emocjonalnego dziecka podczas terapii z fizjoterapeutą.

Analizując wyniki testów można przyjąć, że współpraca dwóch terapeutów przynosi oczekiwane efekty (dziewięcioro na dziesięć dzieci potwierdziło ich skuteczność)

Pozytywny wpływ udziału drugiej osoby w procesie terapeutycznym najbardziej zauważalny był podczas pracy manualnej z dzieckiem. Większość z dzieci nie reagowała na dotyk dzięki temu fizjoterapeuta mógł pracować znacznie dłużej i efektywniej.

Terapeuta mógł skupić się dłużej na pracy z ciałem dziecka jednocześnie nie poświęcając czasu na wyciszanie trudnych emocji zakłócających przebieg terapii.

Proces terapeutyczny przebiegał harmonijnie i ciekawiej dla dziecka, wspierając zarówno nie tylko ruchowy ale także poznawczy i emocjonalny dziecka.

Kompleksowość oddziaływań terapeutycznych przyspiesza i wzmacnia proces osiągniętych celów.

Jest zarówno korzyścią wymierną dla dziecka jak i terapeuty.

ZAŁĄCZNIKI

Scenariusze synergicznie prowadzonych zajęć podzielonych na zadania fizjoterapeuty, psychologa i dogoterapeuty.

Zajęcia terapeutyczne FIZJOTERAPEUTA – DOGOTERAPEUTA

WARIANT 1

1. Powitanie z psem – zapoznanie dziecka ze sposobami powitań z czworonożnym gościem. Podawanie psu smakołyków na powitanie z jednoczesnym przywoływanie psa do siebie. Czas trwania ok 5 minut
2. Zabawa z psem pod okiem dogoterapeuty. Ocena spontanicznej aktywności dziecka przez fizjoterapeutę (pozwala określić na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko oraz ocenić jakość wzorców, którymi ono dysponuje podczas swobodnej i spontanicznej zabawy z psem). Czas trwania – 5 minut

3. Praca manualna fizjoterapeuty z dzieckiem. Pies odpoczywa głaskany przez dogoterapeutę lub zabawa pokazowa pieska z dogoterapeutą w celu odwrócenia uwagi od czynności wykonywanych przez fizjoterapeutę. Czas trwania – 15 minut
4. Pieski pokonują przeszkody – zabawa ruchowa. Ustawiamy tor przeszkód, wykorzystując sprzęt (ławeczka, maty z wypustkami, wyspy, ścieżka sensoryczna). Rozmieszczamy przeszkody w pewnej odległości od siebie, odpowiednio dostosowane do możliwości dziecka. Dziecko wraz z psem pokonuje przeszkody. Czas trwania – 15 minut
5. Relaks z psem – wyciszenie dziecka, delikatny masaż dziecka wykonywany przez fizjoterapeutę. Instruktaż zadań domowych. Czas trwania – 5-7 minut
6. Pożegnanie się z psem

WARIANT 2

1. Powitanie z psem – zapoznanie dziecka z psem, przywitanie psa. Czas trwania ok 5 minut
2. Zabawa z psem pod okiem dogoterapety.. Ocena spontanicznej aktywności dziecka przez fizjoterapeutę (pozwala określić na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko oraz ocenić jakość wzorców, którymi ono dysponuje podczas swobodnej zabawy z psem). Czas trwania – 5 minut
3. Praca fizjoterapeuty z dzieckiem. Pies odpoczywa lub zabawa pokazowa pieska z dogoterapeutą w celu odwrócenia uwagi od czynności wykonywanych przez fizjoterapeutę. Czas trwania – 15 minut
4. Krótka zabawa z psem dziecka pod kontrolą dogoterapeuty. Czas trwania 5 minut
5. Praca fizjoterapeuty z dzieckiem. Pies odpoczywa lub zabawa pokazowa pieska z dogoterapeutą w celu odwrócenia uwagi od czynności wykonywanych przez fizjoterapeutę. Czas trwania – 15 minut
6. Krótka zabawa z psem dziecka pod kontrolą dogoterapeuty. Czas trwania 5 minut
7. Relaks z psem i pożegnanie psa. Głaskanie, czesanie, przytulanie. Czas trwania – 5 minut

Zajęcia terapeutyczne FIZJOTERAPEUTA – PSYCHOLOG

WARIANT 1

1. Rozmowa psychologa z rodzicem. Czas trwania - 5 minut.
2. Ocena spontanicznej aktywności dziecka przez fizjoterapeutę podczas zabawy dziecka z psychologiem. Czas trwania ok 5 minut.
3. Wykonanie testów funkcjonalnych u dziecka przez fizjoterapeutę wspomagane przez zabawę psychologa z dzieckiem. Czas trwania ok 5 minut
4. Praca właściwa fizjoterapeuty. Odwracanie uwagi dziecka przez psychologa (pokazywanie obrazków, śpiewanie piosenek, rozmowa z dzieckiem itd.) Czas trwania ok 25 minut.
5. Zabawa i praca psychologa z dzieckiem i korekta postawy dziecka przez fizjoterapeutę. Czas trwania ok 10 minut.

WARIANT 2

1. Rozmowa psychologa z rodzicem. Czas trwania - 5 minut.
2. Zabawa psychologa z dzieckiem – ocena spontanicznej aktywności dziecka przez fizjoterapeutę, a także psycholog ocenia rozwój poznawczy dziecka. Czas trwania - 5 minut.
3. Praca manualna fizjoterapeuty z dzieckiem wspomagana odwracaniem uwagi dziecka przez psychologa (śpiewanie, pokazywanie obrazków, rozmowa z dzieckiem). Czas trwania - 25 minut.
4. Zabawa psychologa z dzieckiem i korekta postawy podczas zabawy dziecka przez fizjoterapeutę, a także praca manualna na danej części ciała dziecka. Czas trwania - 10 minut.
5. Terapia ruchowa dziecka wykonywana przez fizjoterapeutę. Psycholog motywuje dziecko do wykonywania zadań ruchowych i pokonywania związków z ruchem trudności. Czas trwania - 15 minut.

6. Zabawa psychologa z dzieckiem i korekta postawy podczas zabawy dziecka przez fizjoterapeutę lub zabawa psychologa z dzieckiem w zaproponowanej przez fizjoterapeutę skorygowanej pozycji. Czas trwania - 10 minut.
7. Relaks dziecka - wyciszenie prowadzone przez psychologa, delikatny masaż dziecka wykonywany przez fizjoterapeutę. Czas trwania - 5 minut.



Fizjoterapeuta:

- praca nad stymulacją czucia głębokiego
- praca manualna na miednicy
- ćwiczenia stymulujące równowagę – stymulacja naprzemiennego obciążania stron ciała
- wzmacnianie mięśni posturalnych

Dogoterapeuta:

- Pies motywuje do wykonania ćwiczeń



- Odwraca uwagę dziecka od czynności manualnych
- Pies wspomagany przez dogoterapeutę np. porusza huśtawką



Fizjoterapeuta:

- Praca manualna fizjoterapeuty: kompresja na biodra i ramiona
- Wspomaganie przenoszenia ciężaru ciała
- Wspomaganie utrzymania prawidłowej pozycji siedzącej (stabilność na ruchomym podłożu)

Dogoterapeuta:

- Odwrócenie uwagi dziecka przez psa
- Pies motywuje do dłuższego czasu trwania ćwiczenia
- Zachęca dziecko do wykonania ćwiczenia



Fizjoterapeuta:

- Praca manualna na prawidłowym ustawieniu miednicy
- Praca na obciążaniu stron ciała w pozycji stojącej

- Kompresja przez biodra w kierunku stóp
- Komunikacja z psem

Dogoterapeuta:

- Pies odbiera zabawki od dziecka
- Pies motywuje do działania
- Pies komunikuje się z dzieckiem



Fizjoterapeuta:

- Praca nad wydłużaniem stron
- Praca mięśni kończyn górnych
- Stymulacja do utrzymania prawidłowej pozycji ciała podczas ruchu

Dogoterapeuta

- Pies odbiera piłeczki od dziewczynki
- Motywuje do powtarzania ćwiczeń



Fizjoterapeuta:

- Wspomaganie chodu poprzez kompresje na biodra, chód po nierównym terenie
- Stymulacja czucia głębokiego
- Schylanie i podawanie jedzenia pieskowi na poduszkach sensorycznych

Dogoterapeuta:

- Aktywacja do działania poprzez zjadanie smakołyków
- Pokonanie przez psa toru przeszkód motywując pacjenta do działania



Fizjoterapeuta:

- Praca manualna fizjoterapeuty na różnych częściach ciała w różnych pozycjach dziecka
- Stymulacja czucia głębokiego

Dogoterapeuta:

- Pies przez swoją obecność wspomaga odwrócenie uwagi od rąk terapeuty
- Wspomaga wydłużyć czas ćwiczenia



Fizjoterapeuta:

- Praca nad małą motoryką
- Stymulacja do utrzymania prawidłowej pozycji ciała

Dogoterapeuta:

- Pies podaje części układanki dziecku
- Pies czuwa przy pacjentce



Fizjoterapeuta:

- Praca manualna na miednicy dziecka
- Rozciąganie mięśni przykurczonych
- Praca obręczy barkowej

Psycholog:

- Odwracanie uwagi od rąk terapeuty
- Aktywna praca psychologa - wspiera obszar poznawczy dziecka
- Współpraca z fizjoterapeutą w zachęcaniu do podnoszenia rąk w celu aktywacji odpowiednich mięśni dziecka



Fizjoterapeuta:

- praca manualna fizjoterapeuty
- wzmacnianie mięśni posturalnych
- wspomaganie przez trzymanie na miednicy dziecka stabilnej i prawidłowej postawy dziecka na niestabilnym podłożu przy unoszeniu rąk po piłkę dziecka

Psycholog:

- Odwracanie uwagi od rąk terapeuty
- Współpraca z fizjoterapeutą - podawanie piłki na odpowiedniej wysokości



Fizjoterapeuta:

- Praca na piłce – wspomaganie utrzymania prawidłowej pozycji podczas aktywności dziecka

Psycholog:

- Rozmawia z dzieckiem, pokazuje zabawki aby uaktywnić dziecko, które utrzymuje prawidłową pozycję (stabilny tułów)



Fizjoterapeuta:

- Praca manualna terapeuty
- Utrzymanie pozycji w prawidłowym dla dziecka położeniu przez ok 10 – 15 minut

Psycholog:

- Odwracanie uwagi dziecka i stymulowanie do zabawy , śpiewanie piosenek w celu utrzymania przez dziecko odpowiedniej i prawidłowej pozycji ciała

ANKIETA PRE TESTOWA

Czy dziecko miało już kontakt z następującymi specjalistami?



	Powód kontaktu	Ogólne wnioski po konsultacji	Czy i od kiedy dziecko zostało objęte terapią?	Czy występował stres u dziecka podczas pierwszego spotkania
psycholog TAK ☐ NIE ☐				
logopeda TAK ☐ NIE ☐				
pedagog TAK ☐ NIE ☐				
terapeuta SI TAK ☐ NIE ☐				
rehabilitant TAK ☐ NIE ☐				

Proszę opisać w jakiej sytuacji lub podczas jakich zajęć występował niepokój u dziecka

.....

.....

ANKIETA POST TESTOWA

1. Jak ocenia Pani pierwsze spotkanie dziecka u fizjoterapeuty podczas testu „Bez stresu do sukcesu”?

.....

.....

2. Czy według Pani/Pana dogoterapeta, psychologa zmniejszył poziom stresu u dziecka?



-
-
3. Czy wg Pani/Pana oceny dogoterapeuta, psycholog przyspieszył pierwszy kontakt z nowym miejscem i terapią dziecka?

-
-
4. Czy wg Pani/Pana oceny dzięki pomocy dogoterapeuty i psychologa fizjoterapeuta mógł wykonać efektywniej swoją pracę?

-
-
5. Czy zauważył Pani/Pan po zajęciach „Bez stresu do sukcesu” zmiany emocjonalne w zachowaniu dziecka?